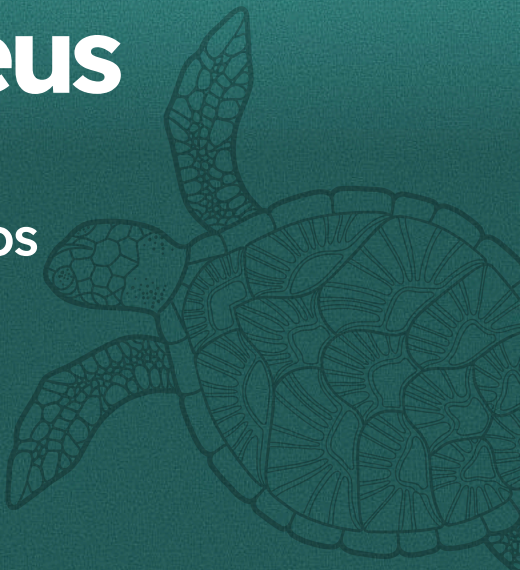
Fluência e seus transtornos

Guia para fonoaudiólogos



Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Afinal, o que é fluência?

Você Sabia?

Para ser considerada fluente, a fala deve ocorrer com mínimo esforço motor, linguístico, emocional e cognitivo. **(Meira, 2002)**

A fluência verbal é definida como a **capacidade de produzir fala contínua, suave e ritmada**, sem interrupções excessivas, pausas longas ou falhas na formulação de palavras.

> Pode parecer fácil falar fluentemente, mas na verdade a fluência é bem complexa: envolve a integração eficiente de aspectos fonológicos, lexicais, morfológicos, sintáticos e semânticos da linguagem com elementos suprassegmentais como ritmo, velocidade, entonação e intenção comunicativa.
>
> (Souza & Cardoso, 2013; Yairi & Seery, 2015; Andrade, 2001)

> Adicionalmente, é necessário que haja integração harmônica entre os sistemas neurológicos envolvidas na linguagem, no ato motor da fala, feedback auditivo e cognição.
>
> (Andrade & Juste, 2001; Buzetti, 2016; Sawyer & Yairi, 2006)

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Principais Transtornos da fluência:

Taquifemia

Saiba Mais

Para mais informações sobre a Taquifemia, acesse o material divulgado pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia.

A fala de uma pessoa com taquifemia é caracterizada principalmente por **uma velocidade de fala percebida como rápida e/ou irregular**.

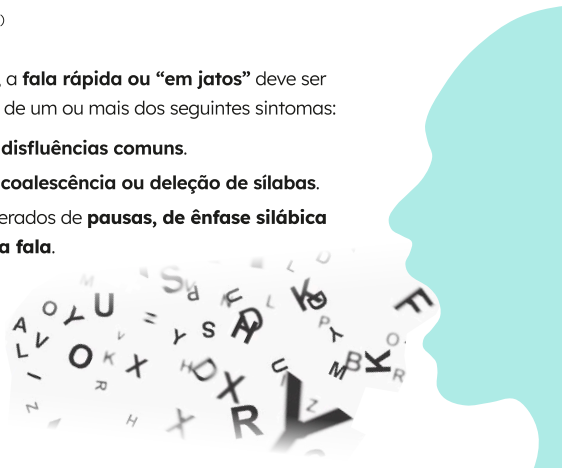
(Andrade, 2001; Ward, 2006)

Estima-se que cerca de **30% das pessoas que gaguejam tenham taquifemia associada**.

(Álvarez, 2023)

Na taquifemia, a **fala rápida ou "em jatos"** deve ser acompanhada de um ou mais dos seguintes sintomas:

- Excesso de **disfluências comuns**.
- Excesso de **coalescência ou deleção de sílabas**.
- Padrões alterados de **pausas, de ênfase silábica ou ritmo da fala**.



Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Principais Transtornos da fluência:

Gagueira

A gagueira é um transtorno da fluência da fala, caracterizado principalmente pela **perda de controle motor e de seu fluxo contínuo, levando a produção de quebras involuntárias no fluxo da fala**, que impedem ou atrasam momentaneamente a sua produção.

A gagueira pode se apresentar de forma transitória ou se cronificar, tornando-se persistente.

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

> No entanto, apesar de algumas características familiares e de linguagem estarem relacionadas a recuperação ou persistência, **não se sabe exatamente o que favorece sua superação em algumas crianças**.
>
> (Soares, 2025)

> Cerca de **80% das crianças que gaguejam superam o quadro de forma espontânea, em até 12 meses após o início**.
>
> (Singer et al., 2022)

Incidência: De 5% a 8% das crianças em idade pré-escolar.

Prevalência: 1% da população adulta, sendo 4H:1M. **(Craig et al., 2002)**

Comece Aqui

Atualmente são considerados dois subtipos de gagueira, a gagueira do desenvolvimento e a gagueira neurogênica. **(SheikhBahaei et al., 2023; Theys et al., 2024)**

Gagueira do desenvolvimento ou do neurodesenvolvimento

Iniciado na infância, é o **transtorno da fluência mais comum e frequente nos consultórios fonoaudiológicos**.

Sua etiologia mais provável é **genética interagindo com fatores ambientais, portanto considerada multifatorial**.

Entende-se que a criança já nasce com as características neurais que predispõem à gagueira do desenvolvimento e as manifestações surgem conforme desenvolvem fala e linguagem.

O fator genético pode pular gerações sem se expressar, mas estima-se uma influência do fator hereditário **de até 84%** (Junuzovic-Zunic, Sinanovic, & Majic, 2021), **podendo ser transitória ou persistente**.

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Existem **diferenças neurais anatômicas e funcionais** entre as crianças que superam e as que não conseguem transpor a gagueira.

Pessoas que gaguejam de forma persistente apresentam:

- **Menor mielinização** nas áreas ligadas à programação motora (Chang & Zhu, 2013).
- Déficit de **percepção de ritmo** (Wieland et al., 2015; Garnett et al., 2023).
- Dificuldades no **processamento fonológico, principalmente memória fonológica** (Walsh et al., 2021)
- **Alterações de funções executivas**, tais como atenção, memória de trabalho, flexibilidade mental e controle inibitório (Smith & Weber, 2017).

Mas a gagueira é psicológica?

Você Sabia?

Estudos apontam para alterações neurológicas estruturais e funcionais envolvendo o circuito Núcleos da Base-Tálamo-Córtex.

(Theys et al., 2024)

Embora a ciência ainda não tenha todas as respostas sobre as causas da gagueira, muito já foi descoberto e têm-se conhecimento suficiente para afirmar que a gagueira **não têm causa emocional**, mas sim uma **causa orgânica neural robusta, que interage com fatores socioambientais**.

> Os **Núcleos da Base** têm um papel determinante na inicialização, duração e transição entre os movimentos de uma sequência motora. Desta forma, acredita-se que a **pessoa que gagueja (PQG) tem dificuldade para planejar, programar e coordenar alguns movimentos da fala**.
>
> (Theys et al., 2024)

A PQG pode apresentar **alterações no sistema dopaminérgico nos Núcleos da Base, o que compromete a seleção, o início e a execução de sequências motoras da fala**.

Por isso, a intervenção deve incluir atenção à qualidade do sono e ao uso consciente de telas, favorecendo a regulação dos níveis de dopamina.

(SheikhBahaei, Millwater & Maguire, 2023)

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

É hora de aprender a diferença!

Disfluências comuns e gagueira

Diferenciar disfluências comuns das disfluências características da gagueira é essencial na avaliação clínica da fluência. Embora **ambas envolvam interrupções na fala, elas diferem em suas causas, manifestações e impacto funcional**.

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Disfluências comuns

> Fazem parte do **funcionamento normal da linguagem e podem ocorrer na fala de qualquer pessoa**. Acontecem **enquanto o falante organiza pensamentos, estrutura frases ou acessa o vocabulário**, especialmente em situações comunicativas mais exigentes. **Não causam tensão, frustração ou evitamento**.
>
> (Andrade, 2006)

- Repetições de palavras inteiras (“quero-quero”).
- Interjeições (“é... então...”).
- Hesitações (ã, eh, m).
- Reformulações espontâneas.

É hora de aprender a diferença!

Disfluências comuns e gagueira

Diferenciar disfluências comuns das disfluências características da gagueira é essencial na avaliação clínica da fluência. Embora **ambas envolvam interrupções na fala, elas diferem em suas causas, manifestações e impacto funcional**.

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Gagueira

> A gagueira é um **transtorno da fluência marcado por rupturas na fala que podem estar associadas a tensão muscular, esforço visível, movimentos faciais ou corporais**, além de reações emocionais negativas, como **frustração e evitação da comunicação**.
>
> (Yairi & Seery, 2015; Guitar, 2014)

- Repetições de sons/sílabas.
- Prolongamentos involuntários.
- Bloqueios abruptos.
- Intrusões de sons.
- Pausas > 2 segundos.

Gagueira neurogênica

Saiba Mais

Quanto antes o contato com o agente infeccioso for finalizado, maior a chance de que a gagueira não se torne persistente.

APLV não IgE mediada costuma ser superada espontaneamente na primeira infância, por isso acredita-se que esta seja uma das possíveis causas de gagueira temporária. **(Aboudiab, 2007; Andrade et al., 2011)**

> A gagueira neurogênica ocorre devido a um **dano cerebral causado por um evento neurológico** como traumatismo físico, infecção, doença ou medicamento que leve a um mal funcionamento cerebral. A gagueira neurogênica geralmente tem **tratamento de difícil evolução devido às lesões, especialmente quando são permanentes**.
>
> (Junuzovic-Zunic et al., 2021; Nikvarz & Sabouri, 2022)

Na literatura, há relatos de gagueira neurogênica após:

- Encefalite.
- Rotavírus.
- Traumatismo cranioencefálico (TCE).
- COVID (Junuzovic-Zunic, Sinanovic, & Majic, 2021).
- Doenças Neurodegenerativas.
- Acidente Vascular Encefálico (AVE).
- **Medicamentos que agem no sistema dopaminérgico** (antidepressivos ou antipsicóticos) ou montelucausto de sódio (usado para rinite e asma) - “Gagueira medicamentosa”. (Nikvarz et al., 2022).
- **Infecções causadas por estreptococos do tipo A**, quando não tratadas adequadamente. (Alm, 2020; Fidan et al., 2025).
- **Alergia alimentar à proteína do leite da vaca** (APLV) não IGe mediada.

Para além das manifestações físicas...

Intermitência e variabilidade da gagueira

A gagueira **não tem causa emocional, mas pode levar a consequências emocionais complicadas e trazer grande impacto à vida social, educacional e profissional** do indivíduo que gagueja.

(Yaruss & Quesal, 2004; Craig et al., 2002)

Como as **disfluências ocorrem de maneira involuntária e intermitente, a PQG não sabe exatamente o momento ou a intensidade em que uma disfluência acontecerá, nem qual será a reação do seu interlocutor. Isso pode gerar medo, insegurança e ansiedade social**, levando a comportamentos de evitação de palavras e/ou de situações comunicativas.

(Ferreira, 2019; Walsh, Christ, & Weber, 2021)

É importante conhecer os principais fatores responsáveis pela **intermitência e variabilidade** da gagueira.

(Alm, 2021; SheikhBahaei, Millwater, & Maguire, 2023)

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Para além das manifestações físicas...

Intermitência e variabilidade da gagueira

Dinamismo dos níveis de dopamina ao longo do dia

> É importante orientar as PQG e seus familiares sobre atividades que exacerbam a produção de dopamina, garantindo sono regular e de qualidade, além de não exagerar no uso de telas.
>
> (Alm, 2021; Jacobs, Merlo, & Briley, 2021)

Nível de demanda dos contextos linguísticos, sociais e cognitivos

> É comum que a gagueira se manifeste com mais intensidade ao narrar eventos do dia a dia, o que exige maior organização linguística, do que ao responder perguntas com respostas curtas e objetivas.
>
> (Smith & Weber, 2017; Briley, Merlo, & Ellis, 2022)

Da mesma forma, é esperado aumento da gagueira para falar diante de um público maior, situação em que a pessoa precisa organizar o conteúdo a ser dito, lidar com a forma de fala, com questões emocionais e atencionais, exigindo acionamento de múltiplas áreas neurais de forma sincrônica, incluindo uso de funções executivas.

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Quando realizar a avaliação?

A avaliação fonoaudiológica é **indicada** se a resposta for **SIM** para 1 ou mais dessas questões:

Criança em idade pré-escolar

- **Menino**.
- Histórico positivo na **família** para gagueira ou dificuldade de linguagem?
- Gagueja há **3 meses ou mais**?
- Apresenta **concomitantes físicos**?
- Está mais **retraído ou evitando situações comunicativas**?
- Começou a gaguejar **após 3 anos e meio**?
- Tem **frustração** ou questiona o **porquê** a fala esta “assim”?
- A gagueira tem **incomodado ou preocupado** a família?
- A criança apresenta **outras alterações** de fala ou linguagem?

Criança em idade escolar, adolescentes e adultos

- Há **queixa de fluência** (da própria pessoa, familiares ou conhecidos)?

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Quais aspectos avaliar?

Fluência

Identificar o tipo e a frequência das disfluências em diferentes contextos: (fala espontânea, leitura, resposta a perguntas, nomeação de figuras, imitação de palavras e frases, e fala decorada, como contar de 1 a 20).

(Andrade et al., 2011; Anjos, Marconato, & Oliveira, 2021)

Averiguar se existem comportamentos de fuga, como por exemplo: evitar o uso de determinadas palavras, usar sinônimos, uso excessivo de hesitações, evitar o contato visual.

(Ferreira, 2019).

Duração média das disfluências e sua oscilação ao longo da avaliação.

(Smith & Weber, 2017)

Analisar o impacto funcional na comunicação e inter relações, explorando a relação do indivíduo com sua fala e nas relações sociais.

(Yaruss & Quesal, 2004; Anjos, Marconato, & Oliveira, 2021)

Verificar a presença de comportamentos de luta e esforço, como tensão muscular, movimentos de cabeça ou bloqueios.

Quais aspectos avaliar?

Aspectos que interferem na Fluência

Investigar o desenvolvimento linguístico e as habilidades de linguagem, principalmente consciência fonológica e memória fonológica.

(Andrade, 2017; Polikowsky et al., 2025)

Investigar o sono e referenciar a profissionais especialistas na área quando necessário, já que vários fatores impactam na qualidade do sono e, portanto, na fluência da fala (bruxismo, AOS, refluxo, comportamento).

(Jacobs, Merlo & Briley, 2021)

Analisar aspectos relacionados a percepção auditiva, principalmente aspectos temporais da percepção do ritmo.

(Wieland et al., 2015; Garnett et al., 2023)

Analisar ritmo, prosódia e entonação, já que alterações nesses aspectos podem coexistir com a gagueira.

Avaliação da Fluência

Sugestão de Leitura

Anjos, Marconato, & Oliveira, 2021

Crianças até 12 anos

- Infantil: ABFW capítulo 3 - Protocolo de fluência com gravações e transcrições (Andrade et al., 2011)
- Adolescentes e Adultos com Gagueira: fundamentos e aplicações clínicas (Andrade et al., 2017)

Adolescentes e Adultos

- Versão Brasileira do protocolo Overall Assessment of the Speaker´s Experience off Stuttering – Adults OASES-A (Bragatto et al, 2010).
- Protocolo mãos para baixo (SFA, Chmela) (Anjos, Marconato, & Oliveira, 2021).
- Protocolo escada das minha habilidades (Anjos, Marconato, & Oliveira, 2021).

Quando intervir?

Mesmo se a criança for muito pequena?

Sim!

- **Oriente** os pais sobre o que é gagueira (Bloodstein & Ratner, 2008; Guitar, 2019).
- **Investigue o sono** e ajude a corrigir **qualquer dificuldade que atrapalhe o desenvolvimento da criança**.
- Ajude-os a **promover fluência** (detalhado mais a frente) e **construir autoestima**.
- Estimule as **áreas do neurodesenvolvimento que dão suporte à fluência** (detalhado mais a frente). (SheikhBahaei, Millwater & Maguire, 2023; Polikowsky et al., 2025).

Lembre-se: NÃO ESPERE!!! Quanto antes iniciarmos o tratamento para gagueira, melhor!

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Fonoterapia para crianças: objetivos e abordagens

Você Sabia?

Caso a criança tenha percepção de sua gagueira, garantir que ela se sinta bem com sua fala, que entenda que às vezes a fala fica difícil, às vezes fácil, e que está tudo bem isso acontecer.

(Yairi & Ambrose, 2013).

FONOAUDIÓLOGOS: Sua fala precisa ser modelo que promove fluência: fale um pouco mais devagar, suave e melodiosamente.

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Objetivos

- Reduzir esforço na fala (Bloodstein & Ratner, 2008; Guitar, 2019).
- Promover fluência.
- Fortalecer autoestima.

Abordagens

- **Indireta**: ambiente acolhedor, escuta ativa.
- **Direta**: conscientização, modelagem da fluência (fala discretamente mais lenta, melodiosa e suave) e modificação da gagueira (Guitar, 2019; Conture, 2001).

Família

> Uma das formas de promover a mielinização nos núcleos da base é a repetição de estímulos e ações. Portanto, precisamos garantir muitos momentos que promovam fluência, dentro e fora da clínica.
>
> (Polikowsky et al., 2025; Fidan, Ceyhan & Fidan, 2025)

- Permita que os pais participem pelo menos de parte da sessão de fonoterapia.
- Sugira momentos (5 a 15 minutos) diários de interação entre um adulto da família e a criança (Singer, Hessling, Kelly, Singer & Jones, 2020).

Fonoterapia para crianças:

Aspectos que dão suporte para desenvolvimento da Fluência

- Percepção auditiva: memória auditiva, resolução temporal, discriminação e ordenação temporal.
- Processamento fonológico: consciência e memória fonológica. (Andrade et al., 2011; Soares, Britto & Lemos, 2024)
- Interação inter-hemisférica.
- Funções executivas, principalmente atenção alternada e controle inibitório. (Smith & Weber, 2017; Walsh, Christ & Weber, 2021)
- Sono: número de horas, regularidade, respeito ao Ciclo Circadiano e qualidade do sono. (Jacobs, Merlo & Briley, 2021; Singer, Otieno, Chang & Jones, 2022)

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Comece Aqui

O objetivo dessas orientações é criar um ambiente familiar acolhedor, que diminua a ansiedade comunicativa, fortaleça a autoestima e favoreça o desenvolvimento natural da fala.

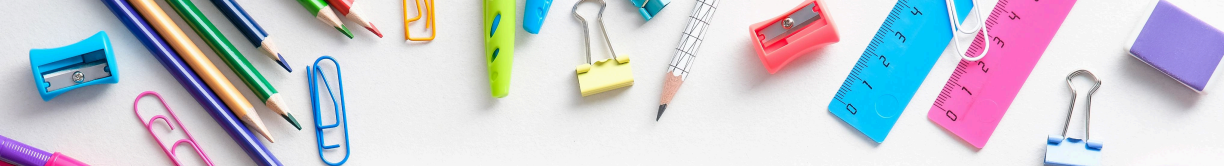
Orientações aos pais

O **apoio da família** é fundamental para o **desenvolvimento da comunicação e da autoestima** da criança que gagueja. Pais e cuidadores desempenham papel central no processo terapêutico, tanto ao **incentivar um ambiente de fala seguro quanto ao colaborar com a equipe fonoaudiológica**.

- Ouvir com atenção e paciência, mantendo contato visual e interesse pelo que a criança diz, sem apressá-la.
- Evitar corrigir ou pedir para "falar devagar" durante momentos de fala espontânea, isso pode aumentar a tensão.
- Reservar momentos tranquilos de conversa, sem pressa ou distrações, favorecendo uma comunicação mais fluida.
- Modelar uma fala suave e pausada, sendo modelo comunicativo.
- Valorizar o conteúdo da fala e não a forma como é dito, reforçando conquistas e interesses.
- Reduzir situações de pressão para falar, principalmente diante de grandes grupos ou em momentos de ansiedade.
- Manter diálogo constante com o fonoaudiólogo, compartilhando observações e dúvidas sobre a evolução da fala.
- Evitar comparações com irmãos ou colegas, focando no progresso individual da criança.

(Instituto Brasileiro de Fluência, 2020)

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia



Orientações à escola

A **parceria entre família, escola e equipe fonoaudiológica** é essencial para o acompanhamento de estudantes que gaguejam. **Professores e equipe pedagógica devem receber informações claras sobre as características da gagueira**, seu impacto na comunicação e estratégias que favoreçam a participação e o bem-estar do aluno.

- Evitar correções diretas da fala (ex.: “fala devagar” ou “respira”) durante a participação em sala.
- Garantir tempo suficiente para o aluno se expressar, evitando interrupções ou completando frases.
- Oferecer oportunidades de fala em um ambiente acolhedor, respeitando o ritmo e as preferências do estudante.
- Promover a conscientização da turma sobre a diversidade na comunicação, prevenindo situações de bullying.
- Adaptar atividades orais quando necessário, sem restringir a participação, mas oferecendo alternativas (ex.: apresentações em grupos menores ou com preparação prévia).
- Manter comunicação contínua com a família e o fonoaudiólogo para acompanhar a evolução e ajustar estratégias.

(Instituto Brasileiro de Fluência, 2020)

Fique Atento! O objetivo dessas orientações é criar um ambiente escolar seguro, que reduza a pressão sobre a fala, incentive a autoestima e permita que o estudante desenvolva seu potencial acadêmico e social.

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Posso ajudar dando dicas de como falar melhor?

Algumas frases ditas com a intenção de ajudar e tranquilizar o indivíduo como “calma, respira”, “para, pensa no que vai falar primeiro” ou até mesmo completar a palavra ou frase, na verdade NÃO AJUDAM!

- A pessoa que gagueja pode pensar que **sua forma de falar não agrada ao ouvinte, comprometendo sua autoestima**.
- Portanto, a melhor forma de ajudar a pessoa no momento de gagueira, é **ouvi-la pacientemente, valorizando o que ela diz**.
- Isso **promove conforto comunicativo, autoestima, e segurança** demonstrando que **o que ela diz tem valor, com ou sem disfluências**.

(Instituto Brasileiro de Fluência, 2020)

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Fonoterapia para adolescentes: objetivos e abordagens

Você Sabia?

OBJETIVOS:

- Abordagem neurocognitiva;
- Fluência contextualizada: ritmo, encadeamento, prolongamento;

Abordagens terapêuticas: A adolescência exige uma abordagem terapêutica sensível e personalizada.

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Vínculo Terapêutico

- Escuta empática: ambiente seguro e acolhedor (Guitar, 2019).
- Autonomia: adolescente como protagonista.
- Confiança: espaço livre de julgamentos (Packman & Onslow, 2017).

Comunicação funcional

- Vai além da fluência: foco em expressão e interação (Rodrigues & Gonçalves, 2017).
- Situações reais: escola, redes sociais, entrevistas (Rodrigues & Gonçalves, 2017).
- Estratégias: ensaios, role-playing, reflexão guiada (Rodrigues & Gonçalves, 2017).

Família & Escola

- Orientar familiares e professores (Instituto Brasileiro de Fluência, 2020)
- Intervenções sistêmicas quando o ambiente influencia (Instituto Brasileiro de Fluência, 2020);

Cognitivo-emocional

- Enfrentar crenças negativas;
- Fortalecer autoestima e identidade;

Fonoterapia para adultos: objetivos e abordagens

Você Sabia?

A gagueira na vida adulta impacta comunicação, relações e carreira. A terapia deve ser personalizada, respeitando a história e os objetivos do paciente.

RECURSOS: Apps, vídeos e plataformas digitais (Maisfono, 2022); Abordagem interdisciplinar quando necessário.

Objetivo

Melhorar fluência, segurança e qualidade de vida.

Gestão Emocional

- Ressignificação de crenças limitantes
- Enfrentamento de situações desafiadoras (reuniões, entrevistas) (Andrade, 2017).
- Técnicas: mindfulness, respiração, dessensibilização (Schröter, 2024).

Fluência de fala

- Abordagem Neurocognitiva (Andrade, 2017).
- Conhecimento e propriocepção sobre a gagueira em seu corpo (Andrade, 2017).
- Estratégias: pull out, prolongamento, encadeamento, pausas, ritmo
- Treino em contextos reais e gravações para feedback
- Estímulo à espontaneidade e autonomia comunicativa (Andrade, 2017).

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Mitos sobre a gagueira

Fique Atento! Concepções equivocadas sobre a gagueira dificultam e atrasam o acesso ao diagnóstico e à intervenção adequados, além de contribuir para o estigma social enfrentado por pessoas que gaguejam.

(Stuttering Foundation, 2025; IBF, 2025; Abragagueira, 2021)

“A gagueira é psicológica, causada por nervosismo ou por um susto.”

> Na realidade, a gagueira é neurológica e interage com fatores sócio-emocionais que podem piorar suas manifestações, mas não são a sua causa.
>
> (Chang et al., 2009; Brown et al., 2005; Yairi & Ambrose, 2013)

“Pessoas que gaguejam não são inteligentes.”

> Pelo contrário, tendem a ser mais observadoras e perspicazes; muitas vezes apenas deixam de falar o que sabem por receio de gaguejar em público.
>
> (Stuttering Foundation, 2025; IBF, 2025; Abragagueira, 2021)

“Levar um susto faz a pessoa parar de gaguejar.”

> Entende-se que o cérebro de quem gagueja precisa se desenvolver em anatomia e funções específicas para superar a gagueira, não sendo afetado por eventos isolados.
>
> (Chang et al., 2009; Brown et al., 2005)

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Mitos

Mitos sobre a gagueira

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

“A criança começou a gaguejar porque imitou o amigo da escola” ou “a gagueira pode pegar/passar de uma pessoa para outra.”

> O convívio com outras pessoas que gaguejam não modifica a forma como o cérebro de alguém processa sua própria fala.
>
> (Drayna, 2010; Barbosa & Chiari, 2005)

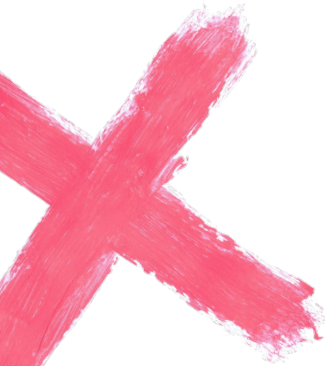
“A criança vai parar de gaguejar sozinha.”

> A maioria das crianças que gaguejam (CQG) apresenta recuperação espontânea, sem intervenção. Entretanto, na gagueira corre-se contra o tempo. O ideal é otimizar o período de plasticidade neuronal e desenvolver as funções necessárias para que o indivíduo se desenvolva plenamente. Portanto, recomenda-se intervenção em tempo adequado.
>
> (Barbosa & Chiari, 2005; Stuttering Foundation, 2025)

“A criança gagueja para chamar a atenção dos pais.”

> Nenhuma criança gagueja intencionalmente para chamar atenção; a gagueira ocorre de forma involuntária, sem controle do indivíduo. Observa-se apenas que as CQG tendem a ser mais sensíveis e reativas do que crianças que não gaguejam.
>
> (Drayna, 2010; IBF, 2025)

Mitos sobre a gagueira



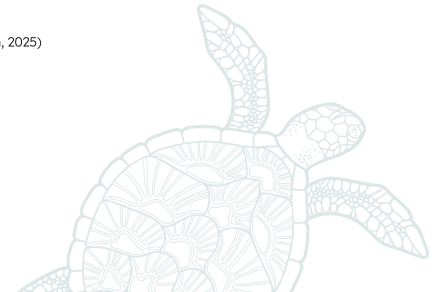
Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

“A pessoa gagueja porque pensa mais rápido do que fala.”

> Não há evidências de que pessoas que gaguejam (PQG) pensem mais rápido do que falam. O que ocorre é uma falha na programação motora da fala, que impede que os movimentos sejam executados na velocidade pretendida pelo falante.
>
> (Chang et al., 2009; Brown et al., 2005)

“A criança começa a gaguejar por cobrança dos pais.”

> Não há evidências de que fatores parentais causem a gagueira. Entretanto, os pais podem auxiliar a criança durante o período em que a gagueira persiste, ajudando a minimizar a severidade e apoiando estratégias que favoreçam a superação da gagueira.
>
> (Barbosa & Chiari, 2005; Stuttering Foundation, 2025)



Comece Aqui

A alta fonoaudiológica no tratamento da gagueira não deve ser entendida como a eliminação completa de todas as disfluências ou como um ponto final absoluto na trajetória terapêutica.
(Buss & Wertzner, 2016; Guitar, 2006)

Importante considerar: O desejo do paciente de finalizar a terapia, reconhecendo avanços e sentindo-se preparado para evoluir de forma autônoma.
(SBFa, 2021; Guitar, 2006)

Quando posso dar alta para o meu paciente?

> A decisão pela alta não deve ser baseada apenas em parâmetros técnicos ou em reduções numéricas de disfluências, mas em uma análise abrangente da evolução do paciente.
>
> (Oliveira, Juste, & Andrade, 2017; Bortoni-Ricardo & Aragão, 2012)

Por isso, deve-se considerar:

- Ausência ou controle dos comportamentos de fuga e evitamento, bem como a autorregulação e monitoramento da própria fala.
- Desaparecimento ou diminuição dos comportamentos de esforço e tensão muscular durante a fala. (Buss & Wertzner, 2016).
- Apoio familiar e social estruturado, com boa compreensão sobre a natureza da gagueira. (Busanello-Stella & Arcuri, 2011).
- Redução significativa das disfluências típicas da gagueira, com manutenção dessa melhora por um período estável.
- Autonomia comunicativa funcional, ou seja, a pessoa consegue se comunicar de forma eficaz, mesmo apresentando disfluências eventuais. (Bortoni-Ricardo & Aragão, 2012).
- Melhora da autopercepção e da relação emocional com a fala. (Oliveira, Juste, & Andrade, 2017).

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

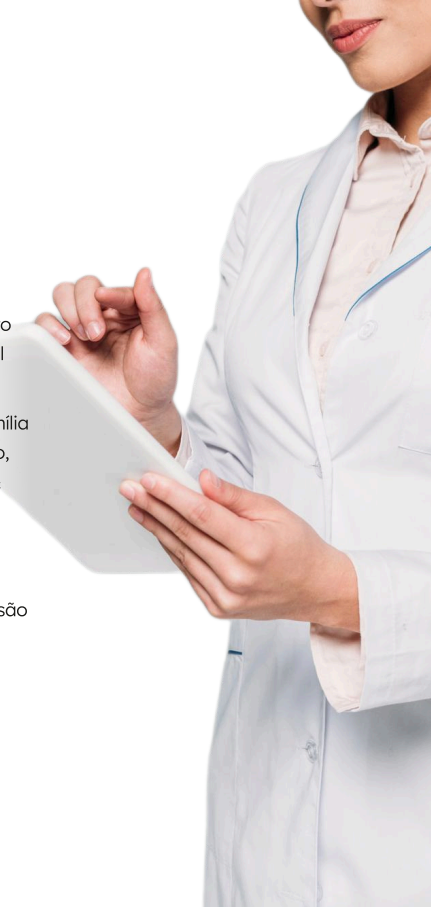
Pontos importantes
sobre a alta

É fundamental que o paciente e a família compreendam que a gagueira não tem cura, mas pode ser tratada com eficácia, promovendo a fluência funcional, conforto ao falar, autonomia e qualidade de vida. Aceitar a própria comunicação é essencial para o sucesso terapêutico. (SBFa, 2021; Busanello-Stella & Arcuri, 2011)

A alta deve ser um processo gradual e assistido, com preparo do paciente e da família para a transição. Esse momento é ideal para reforçar estratégias de enfrentamento, revisar pontos críticos em caso de regressões e consolidar a autoconfiança (Buss & Wertzner, 2016; Guitar, 2006).

Para garantir a manutenção dos resultados, é essencial que o paciente e a família reconheçam os avanços alcançados. Ferramentas como gravações (pré e pós-intervenção), releitura de relatórios iniciais e escalas de avaliação, como o OASES, são recursos valiosos (Oliveira, Juste, & Andrade, 2017; Busanello-Stella & Arcuri, 2011).

Por fim, um diálogo reflexivo sobre os desafios superados contribui para uma alta bem-sucedida. (SBFa, 2021; Bortoni-Ricardo & Aragão, 2012).



SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Autores

Guia elaborado por Grupo de Trabalho do Comitê de Fluência da SBFa - Gestão 2025-2027

Mirela Pollini Caputo - Fonoaudióloga; Mestre em Fonoaudiologia (PUC-SP); Diretora do Instituto Brasileiro de Fluência - IBF.

Cecília Barcelos Camargos Diniz - Discente em Fonoaudiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Clara Lemos Melo Ribeiro - Discente em Fonoaudiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Júlia Machado Glória - Fonoaudióloga pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Juliana Lupo Mereles - Fonoaudióloga; Doutora em Ciências da Saúde e Comunicação Humana; Mestre em Fonoaudiologia (UNESP); Membro Representante do Brasil no Internacional Cluttering Association (ICA).

Sallete Cristina Silva - Fonoaudióloga; Mestre em Ciências Fonoaudiológicas (UFMG).

Luciana Furtado Seacero Granja - Fonoaudióloga docente da PUC-CAMPINAS; Mestre em Ciências da Reabilitação (UNIFESP); Coordenadora do Comitê de Fluência da SBFa.

Erika Queiroga Werkhaizer Soares - Fonoaudióloga; Doutora em Ciências Fonoaudiológicas (UFMG); Mestre em Linguística (UFMG); Vice-coordenadora do Comitê de Fluência da SBFa.

Colaboração: Fga Daniela Verônica Zackiewicz - Oficina de Fluência.

SBFa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia